

Tõenduspõhine praktika ja selle rakendamine



Karin Streimann

Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktorant; Tervise Arengu Instituut

Eestis räägitakse viimastel aastatel palju tõenduspõhisusest, seda nii tervishoiu-, sotsiaal- kui haridusvaldkonnas. Samas on inimestel, organisatsioonidel ja ka valdkondadel erinev nägemus sellest, mida tõenduspõhisus täpsemalt tähendab. Kas tõenduspõhine praktika tähendab ainult tõenduspõhiste sekkumisviiside rakendamist? Millised uuringud on kõige usaldusväärsemad tegevuste tulemuslikkuse hindamisel? Mille poolest erinevad omavahel mõisted *teaduspõhine*, *tõenditeadlik* ja *tõenduspõhine*? Kas ja kuidas saab spetsialist oma töös tõenduspõhist praktikat rakendada?

Mida tõenduspõhine praktika endast kujutab?

Tõenduspõhine lähenemine sai alguse meditsiinis. Eesmärk oli vähendada lõhet olemasolevate teadmiste ning realselt rakendavate raviviiside vahel ning soodustada teadusliku uurimistöö tulemuste arvesse võtmist ametialaste otsuste tegemisel (Rubin ja Babbie 2011). Edmond jt (2006) rõhutavad, et sooviti vähendada „autoriteetide arvamustel” või „eksperthinnangutel” põhinevat praktikat. Üks esimesi definitsioone tõenduspõhise praktika kohta, mida meditsiinis endiselt laialdaselt kasutatakse, rõhutab parima olemasoleva tõendusmaterjali kasutamist, et kohusetundlikult, selgesõnaliselt ja kaalutletult langetada otsuseid patsiendi ravi üle (Sackett jt 1996).

Eestis ei ole ühte ametlikku definitsiooni tõenduspõhisele lähenemisele. Laste ja perede arengukava 2012–2020 (Sotsiaalministeerium 2011) toob välja, et tõenduspõhine

praktika (ingl *evidence-based practice*) kätkeb endas olemasoleva kõrgeima kvaliteediga teadusliku uurimistöö kasutamist tulemusrikkama ja õigustatud avaliku poliitika soodustamiseks. Sotsiaaltöö meetodeid käsitlevas kirjanduses defineeritakse tõenduspõhist praktikat (edaspidi TPP) kui kombinatsiooni teaduslikust uurimistööst tulenevast tõendusmaterjalist, erialasest asjatundlikkusest ja kliendi väärtustest, eelistustest ning eripäradest (Rubin ja Babbie 2011, 26). See tähendab, et spetsialist võtab oma töös alati arvesse usaldusväärsete teadustööde tulemusi ega juhindu üksnes enda professionaalsest kogemusest või varasematest teadmistest (vt joonis 1).

Eriti oluline on tõendusmaterjalile tugine mine valdkondades, kus otsused mõjutavad inimeste tervist ja heaolu ning tegevuste tagajärjed võivad olla pöördumatud. Smith (2004) rõhutab, et kui spetsialisti ametialane tegevus võib teistele inimestele avaldada nii positiivset kui ka negatiivset mõju,



Joonis 1. TPP mudel
(Rubin ja Babbie 2011, 26)

peab spetsialist alati otsima teaduslikku tõendusmaterjali ning võtma seda otsuste langetamisel arvesse. Seejärel saab ta enda kogemustele toetudes valida välja sobivaima ja mõjusaima teaduslikult tõendatud meetodi, mida konkreetse olukorra/juhtumi puhul rakendada (Smith 2004, 12).

Sotsiaaltöö meetodeid käsitlevas kirjanduses defineeritakse tõenduspõhist praktikat kui kombinatsiooni teaduslikust uurimistööst tulenevast tõendusmaterjalist, erialasest asjatundlikkusest ja kliendi väärtustest, eelistustest ning eripäradest.

TPP rakendamine hõlmab lisaks tõendusmaterjali otsimisele ka tõenduspõhiste hindamisvahendite kasutamist ning oma tegevuse järjepidevat hindamist. Seega võib TPP protsessi kirjeldada järgmiselt:

- 1) usaldusväärsete ja valideeritud hindamisvahendite kasutamine kliendi (või sihtrühma) heaolu ja abivajaduse hindamiseks ja vajaduspõhiste sekkumisviiside kaardistamiseks
- 2) sekkumiskava koostamine, võttes arvesse – olemasolevat parimat tõendusmaterjali sekkumisviiside kohta, mis varem on sama

sihtrühma ja probleemide puhul andnud positiivse tulemuse

- praktiku erialast asjatundlikkust konkreetse kliendi vajaduste mõistmisel
- kliendi enda väärtusi, eelistusi, eripära ja olukorda

3) tulemuste hindamine, kasutades tõenduspõhiseid hindamisvahendeid, et teha kindlaks, kas rakendatud sekkumisviis tõi kaasa soovitud muutuse. Kui ei toonud, siis TPP rakendaja valib alternatiivse sekkumisviisi, võttes jälle arvesse olemasolevat parimat teaduslikku tõendusmaterjali ning seejärel hindab sekkumise tõhusust (Rubin ja Babbie 2011, 26).

TPP pole sama, mis sekkumine või programm

Sageli aetakse TPP segamini mõistetega *tõenduspõhine sekkumine* ja *tõenduspõhine programm* ning seetõttu järeldatakse, et TPP tähendab ainult eksperimentaaluuringu tulemustega kinnitatud sekkumise rakendamist. Päris nii see siiski ei ole. Rubin ja Babbie (2011, 27) rõhutavad TPP puhul erialase asjatundlikkuse ja kliendi väärtuste ja eripära olulisust. TPP ei ole lõplik nimekiri sekkumisviisidest, mida spetsialist peab kasutama, sest nende puhul on varemalt läbi viidud eksperimentaaluuringuid. Kui spetsialisti teadmised kliendi olukorra ja eripära kohta annavad alust arvata, et antud sekkumine kliendile ei sobi, võib spetsialist sellele teadmisele tuginedes mitte rakendada sekkumist, mis teoreetiliselt küll võiks sobida, ent reaalses elus mitte (*ibid*, 28).

Drisko ja Grady (2015, 275) pakuvad välja lihtsa selgituse, eristamaks TPPd tõenduspõhisest sekkumisest. Nad kirjeldavad TPPt kui protsessi, mis võib viia otsuse langetamiseni, et tõenduspõhise sekkumise rakendamine on konkreetse juhtumi korral parim lahendus. Tõenduspõhine sekkumine

on sealjuures vahend, mida rakendatakse TPP käigus. Tõendus põhinev sekkumine hõlmab erinevaid tegevusi (nt teenused, toetused vm abi), mis on uuringute põhjal ja erinevates kontekstides andnud tulemusi just nende näitajate suhtes, mida loodetakse mõjutada (Edovald 2015, 63). Kuid TPP kui protsess sisaldab endas ka kliendi eelistuste ja väärtuste ning spetsialisti enda ametialase kogemuse arvesse võtmist lõpliku otsuse tegemisel, millist sekkumisviisi kasutada (Drisko ja Grady 2015, 275). Seega võib TPP sisaldada endas mõne tõendus põhise sekkumise rakendamist, aga mitte alati.

Veelgi kitsam termin on tõendus põhine programm, mida võib defineerida kui kindla korraldusega praktika kogumit, mis on testitud ja efektiivne (Edovald 2015, 65). Eestis rakendatavad tõendus põhised programmid on näiteks vanemlusprogramm „Imelised aastad”, koolipõhine kiusamisvastane programm KiVa, riskikäitumist ennetav klassipõhine programm VEPA Käitumisoskuste Mäng ja tõsiste käitumisprobleemidega lastele ja noortele suunatud mitmedimensioonilise pereteraapia programm (MDFT). Kõigi nende programmide puhul on mujal maailmas läbi viidud randomiseeritud kontrollkatseid (ingl *randomized controlled trials* ehk RCT), mis on tõendanud soovitud mõju saavutamist, nt on vähenenud kiusamine või laste vaimse tervise probleemid.

Mõisted tõenditeadlik ja teaduspõhine

Eestis kasutatakse ka mõisteid *tõenditeadlik* (ingl *evidence-informed*) ja *teaduspõhine* (ingl *science-based*). Nii Talur (2013) kui Bamber (2013) kirjeldavad tõenditeadlike praktikaid, mis põhinevad erinevate kogemuste, hinnangute ja ekspertteadmiste loimimisel tõendusmaterjaliga parimatest kättesaadavatest uuringutest. Mille poolest see aga erineb

TPPst, mis samuti integreerib kliendi eripära spetsialisti erialase asjatundlikkuse ja parima tõendusmaterjaliga? Nevo ja Slanim-Nevo (2011) eristavad tõenditeadlikku praktikat TPPst eeskätt selle poolest, et tõenditeadlik praktika on enam kliendikeskne, klienti kaasav ja tõendusest informeeritud, kuid alati ei põhine tõendusel. Tõenditeadlik praktika võtab arvesse erinevaid uurimistöö tulemusi, olgu need siis saadud kas kvalitatiivsest või kvantitatiivsest uurimistööst. Epstein (2009) pooldab tõenditeadlikku lähenemist TPPst enam, sest tema hinnangul TPP piirab otsuseid selles osas, mis on sobiv sekkumisviis ja mis seda pole. Tõenditeadlik lähenemine on mitmekülgsem ja rikkalikum, see võtab arvesse erinevat tõendusmaterjali ning seeläbi laiendab võimalike sekkumisviiside loetelu. Samas näevad ka mitmed TPP pooldajad, et TPP käigus saab arvesse võtta ja väärtustada nii kvalitatiivsetest, kombineeritud kui juhtumiuuringutest kogutud andmeid (Nevo ja Slanim-Nevo 2011, 1194).

Slavin (2015) püüab omakorda selgitada erinevust teaduspõhise ja tõendus põhise sekkumise vahel. Tema hinnangul on termin *teaduspõhine* liiga lai ja ebaselge, sest enamus otsuseid ja tegusid põhinevad alati mingisugustel teadmistel. Igasugust sekkumisviisi võib nimetada teaduspõhiseks, kui see lähtub kindlast teooriast. Samas puudub paljudel sekkumisviisidel igasugune tõendusmaterjal mõju kohta ehk pole teada, kas need ka tegelikult positiivsete tulemusteni viivad. Tõendus põhise sekkumist rakendades on suurem tõenäosus jõuda soovitud tulemusteni, hoida ära ressursside asjatut kulutamist ning teha parim võimalik klientide heaks (Edovald 2015, 64).

Millised uuringud on usaldusväärsemad?

Tõendus põhine praktika tõstab esile tõendus-

materjali või olemasoleva uurimistöö arvesse võtmist. Mis aga on üldse usaldusväärne tõendusmaterjal? Rubin ja Babbie (2011) rõhutavad, et praktikud peavad teadma, mis tüüpi uuringud on teistest usaldusväärsemad ja millist tüüpi tõendusmaterjali võib kõige vähem usaldada, kui hinnatakse sekkumise tõhusust. Tõendusmaterjali hierarhias kuuluvad viimasesse rühma näiteks tagasiside- ja rahuloluküsimustikud, ekspertide arvamused ja juhtumikirjeldused. Sellised andmed võivad anda küll vajaliku esmase info, aga ei ole küllaldased põhjus-tagajärge seose hindamiseks. Usaldusväärsem tõendusmaterjal sekkumise efektiivsusest pärineb süstemaatilistest ülevaadetest ja meta-analüüsides, randomiseeritud kontrollkatsetest ja kvaasi-eksperimentidest (Rubin ja Babbie 2011, 35). Sackett ja kolleegid (1996) aga toonitavad, et TPPs oleneb sobiv tõendusmaterjal uurimisküsimusest ning ei saa väita, et TPP tähendaks ainult randomiseeritud kontrolluuringutega arvestamist. Kui soovime saada ülevaadet probleemi levimusest, siis leiame vastuse hoopis läbilõikeuuringutest. Spetsialistil on vaja teada, millised uurimisviisid tema küsimuse puhul kõige paremini sobivad ning kuidas läbi viidud uuringute kvaliteeti hinnata.

Mitmete juhtumite korral aga pole olemas tõendusmaterjali, mida otsuste langetamisel arvesse võtta. Tõendusmaterjali puudumine teatud sekkumisviisi kohta ei tähenda automaatselt, et sekkumine pole tõhus ning seda ellu viima ei peaks. Sellisel juhul tuleks pigem läbi mõelda, kuidas saaks ise sekkumise mõju põhjalikumalt hinnata. Mõnel juhul ei pruugi leiduda infot tõhusa sekkumise kohta, küll aga leidub infot selle kohta, mida ei tohiks teha. Kuigi iga kord pole täpseid vastuseid leida, on oluline neid siiski otsida. See aitab vähendada ebatõhusate või isegi kahjulike sekkumisviiside rakendamist.

Mõned teadlased on skeptilised tõenduspõhise praktika rakendamise suhtes sotsiaaltöö valdkonnas ning leiavad, et selline lähene mine vähendab professionaalse hinnangu ja kaalutluse tähtsust (Webb 2001). Samas on

TPP rakendamise neli sammu on abiks igale spetsialistile, kes soovib oma tegevustes ja otsustes enam tõendusest lähtuda.

uurijad leidnud, et tõenduspõhise praktika osas teadmisi omavad spetsialistid pakuvad kõrgema kvaliteediga ja tõhusamaid teenuseid võrreldes traditsioonilisi võtteid rakendavate spetsialistidega (Choudry, Fletcher ja Soumerai 2005; Norman ja Eva 2005). Positiivsemaid tulemusi aitab selgitada TPP põhiolemus: TPP ei tunnista automaatselt seda, mida autoriteetne või suuremate kogemustega spetsialist ütleb. TPP rakendaja esitab küsimusi ja otsib vastuseid teadustöödest, seab kahtluse alla uskumusi ja oletusi, traditsioone ja autoriteete (Rubin ja Babbie 2011). TPP arendab ka praktikute oskusi elukestvaks õppeks ja toetab uurivat mõtteviisi (Eddy 2005; Zlotnik ja Galambos 2004).

Neli sammu TPP rakendamisel

Uurijad on leidnud, et enamus sotsiaaltöötajatest ei kasuta järjepidevalt teaduslikku uurimistööd, et sellele tuginedes oma tegevusi planeerida (Mullen jt 2005). Sellel on ka mitmeid põhjusi, näiteks spetsialistide piiratud ligipääs teaduslikele andmebaasidele, uuringute puudumine mõnedes valdkondades ja praktikute ajapuudus (Edmond jt 2006). Samas on TPP rakendamise neli sammu abiks igale spetsialistile, kes soovib oma tegevustes

ja otsustes enam tõendusest lähtuda.

Järgnevalt kirjeldan neid samme ühe juhtumi põhjal. Oletagem, et lastekaitse-spetsialisti kliendiks on 13aastane laps, kes on tarvitanud kanepit ning kelle suunas vastuvõtule politsei esmakordse narkosüüteo tõttu. Lapsevanemad annavad spetsialistile teada, et vaimse tervise häireid lapsel diagnoositud pole. Kuidas saab lastekaitsetöötaja last ja perekonda toetada, et ennetada narkootikumide korduvat tarvitamist?

Lastekaitsespetsialist teab, et siiani on selliste juhtumitega tegelemisel vesteldud lapsega kanepi kahjulikkusest ning last hirmutatud võimalike tagajärgede suhtes (nt suunamine kasvatusse eritingimusi vajavate õpilaste kooli). Samuti on kasutatud vestlust endise uimastite tarvitajaga, kes räägib lapsele oma kogemustest. Samas pole spetsialist veendunud, kas need on tõhusad viisid uimasti korduvat tarvitamise ennetamiseks.

Esimeseks tegevuseks TPP puhul on uurimisküsimuse formuleerimine. Siinkohal on abiks mitmesugused meetodikad. Rubbin ja Babbie (2011, 30) pakuvad välja CIAO meetodi, meditsiinivaldkonnas kasutatakse uurimisküsimuse sõnastamisel ka PICOT akronüümi (Riva jt 2012). Eesti keelde võiks seda tõlkida kui KSAT meetodit, kus küsimus peab sisaldama infot järgmiste punktide kohta:

- Klient või kliendirühm (sh kliendi eripära)
- Sekkumisviis, mille rakendamine on kaalumisel
- Alternatiivne sekkumisviis (kui on teada) või tavapärane praktika
- Tulemus (mida mõõdetakse).

PICOT lisab neile neljale veel ühe mõõtme: aja, mille jooksul tulemusi mõõdetakse.

Kirjeldatud juhtumi puhul võiks uurimisküsimuseks olla: kas lapse teavitamine kanepi kahjulikkusest ja tema hirmutamine

(sekkumisviis) on tõhusam, kui mingi muu sekkumisviis (alternatiiv) kanepit tarvitanud 13aastase lapse puhul, kellel ei esine kaasuvaid vaimse tervise häireid (kliendi eripära), ennetamaks kanepi korduvat tarvitamist (tulemus)?

Teiseks tegevuseks on teaduslike tõendusmaterjalide leidmine ja analüüsimine. Praktikul pole tihtipeale nii palju aega kui teadlastel, et teaduslikest andmebaasidest infot otsida. Aja kokkuhoidmiseks tasub tutvuda eeskätt metaanalüüside, süstemaatiliste ülevaadete, raportite ja juhendmaterjalidega, kuhu on kokku kogutud info sekkumisviiside tõhususe kohta. Sealjuures on suureks abiks kaks veebipõhist raamatukogu: Cochrane Collaboration (www.cochrane.org), mis koondab ühte süstemaatilisi ülevaateid olemasolevatest uuringutest meditsiini ja rahvatervishoiu valdkonnas, ning Campbell Collaboration (campbellcollaboration.org), mis koondab sotsiaal- ja kasvatusseaduste materjale.

Kui mõelda tagasi kirjeldatud juhtumile ning uurida teaduskirjandust, siis selgub, et efektiivsemad sekkumisviisid põhinevad vanemlike oskuste arendamisel, lapse sotsiaalsete oskuste arendamisel ja motivatsiooni tõstval lühisekkumisel (Bühler ja Thrul 2015; *United Nations* ... 2015). Samuti selgub tõendusmaterjalist, et tulemusi ei anna teavitamine uimastitest ja nende mõjust, hirmutamine tagajärgedega ning endiste tarvitajate kogemuslugude jagamine. Mis tähendab, et selliste tegevuste mõjul lapse käitumine ei muutu üldse või uimasti tarvitamine võib koguni suurened. Teaduskirjandusest selgub ka see, et võrreldes üle 14aastastega on alla 14aastaste puhul vähem tõhusad ainult nende endi käitumise muutmisele suunatud tegevused (*ibid*).

Tõendusmaterjali hinnates saab spetsialist langetada otsuse, et varem praktiseeritud mee-

todeid rakendades ta positiivse tulemuseni ei jõua ja võib pigem lapsele oma tegevusega kahju teha. Sekkumisviisi lõplikul valikul on oluline arvesse võtta kliendi ootusi ja väärtusi ning kaasata klient otsuse langetamisse. Käesoleva juhtumi puhul saab erinevaid sekkumisviise kaaluda koos perekonna ja lapsega. Koos saab paika panna sekkumise loodatavad tulemused, mida oleks võimalik sekkumise lõpus ka mõõta.

Kolmandaks sammuks on sekkumisviisi rakendamine. Enne sekkumist võib spetsialistil olla tarvis omandada uued oskused sekkumise läbiviimiseks, nt osaleda mõnel koolitusel. Sekkumist võib pakkuda ka mõni teine asutus/spetsialist, kellega lastekaitsetöötaja saab ühendust võtta. Kirjeldatud juhtumi puhul võib spetsialist otsustada, et tegeleb nii lapse sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamisega kui ka vanemate vanemlike oskuste arendamisega.

Antud juhtumi puhul jääb spetsialistile tunne, et lapse teadmised kanepi mõjust on ühekülgsed. Seetõttu võtab ta TPP käigus arvesse ka isikliku eksperthinnangu ning otsustab lisaks sotsiaalsete oskuste arendamisele anda lapsele ja perele tõest infot selle kohta, kuidas aine alaealisele mõjub. Spetsialist teab varasema kogemuse põhjal, et vestlus lapsega peab olema avatud ja teineteist austav, et mõlemal osapoolel oleks võimalus oma seisukohti väljendada ja põhjendada.

Neljas samm on tulemuste/protsessi

hindamine. Sekkumise lõpus saab hinnata, kas eelnevalt paika pandud oodatavad tulemused on saavutatud. Selleks tuleks nii enne sekkumist, sekkumise ajal kui ka selle järel hinnata kliendi käitumist, oskusi, teadmisi või hoiakuid, mida sooviti mõjutada. Vaatluse all oleva juhtumi puhul võib lastekaitse spetsialist kasutada k. a detsembris ilmuvas lapse heaolu hindamise käsiraamatus¹ antud juhiseid eesmärkide seadmiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond saab toetada ja abistada spetsialiste nii lastele ja peredele sobivate tõhusate meetmete leidmisel kui ka hindamise läbiviimisel. Kui lastekaitse spetsialistil on vaja kasutada lisaks mõnda muud hindamisvahendit, on oluline välja selgitada, millised usaldusväärsed hindamisvahendid on eesti keelde kohandatuna olemas ja spetsialistidele kättesaadavad ning kuidas neid kasutada.

Selliseid samme astudes saab spetsialist oma igapäevases tegevuses lähtuda enam teadusliku uurimistöö tulemustest ning seda otsuste langetamisel ja sekkumistegevuste planeerimisel arvesse võtta. Sel viisil tegutsedes avaldab praktiku töö suurema tõenäosusega positiivset mõju kliendi edaspidisele heaolule ning vähendab riski, et spetsialist oma töö käigus abivajajale kahju teeb. **S**

Tänan Karmen Torost kasulike nõuannete eest artikli täiendamisel.

Viidatud allikad

- Bamber, J.** (2013). Noorsootöös tõenditeta hakkama ei saa. *MIHUS*, 14, 6–10.
- Bühler, A., Thrul, J.** (2015). Prevention of Addictive Behaviours. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Luxembourg. <https://doi.org/10.2810/993748>.
- Choudry, N. K., Fletcher, R. H., Soumerai, S.** (2005). Systematic review: The relationship between clinical experience and quality of health care. *Annals of Internal Medicine*, 142, 260–273.

¹ Käsiraamat avalikustatakse Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Vt lähemalt Kadi Lauri artiklit, lk 72–77.

- Drisko, J. W., Grady, M. D.** (2015). Evidence-Based Practice in Social Work: A Contemporary Perspective. *Clinical Social Work Journal*, 43, 274–282. DOI 10.1007/s10615-015-0548-z.
- Eddy, D.** (2005). Evidence-based medicine: A unified approach. *Health Affairs*, 24(1), 9–17.
- Edmond, T., Megivern, D., Williams, C., Rochman, E., Howard, M.** (2006). Integrating evidence-based practice and social work field instruction. *Journal of Social Work Education*, 42, 377–396.
- Edovald, T.** (2015). Tõenduspõhine sekkumine – vaenlane või abimees töös laste ja peredega? *Sotsiaaltöö*, 4, 63–70.
- Epstein, I.** (2009). Promoting harmony where there is commonly conflict: Evidence-informed practice as an integrative strategy. *Social Work in Health Care*, 48, 216–31.
- Mullen, E., Shlonsky, A., Bledsoe, S. E., Bellamy, J. L.** (2005). From concept to implementation: Challenges facing evidence-based social work. *Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice*, 1, 61–84.
- Nevo, I., Slonim-Nevo, V.** (2011). The Myth of Evidence-Based Practice: Towards Evidence-Informed Practice. *British Journal of Social Work*, 41, 1176–1197. doi:10.1093/bjsw/bcq149.
- Norman, G. R., Eva, K. W.** (2005). Does clinical experience make up for failure to keep up to date? *Evidence Based Medicine*, 10(3), 66–68.
- Riva, J. J., Malik, K. M. P., Burnie, S. J., Endicott, A. R., Busse, J. W.** (2012). What is your research question? An introduction to the PICOT format for clinicians. *The Journal of the Canadian Chiropractic Association*, 56(3), 167–171.
- Rubin, A., Babbie, E.** (2011). *Research Methods for Social Work* (7th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Muir Gray, J. A., Haynes, R. B., Scott Richardson, W. S.** (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't, *BMJ*, 312(7023), 71. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>.
- Shaw, I.** (1999). Evidence for Practice. In Shaw, I. Lishman, J. (toim.) *Evaluation and Social Work Practice*. London: Sage.
- Slavin, R. E.** (2015). Evidence-Based vs Evidence-Proven. www.huffingtonpost.com/robert-e-slavin/evidence-based-vs-evidenc_b_7614582.html (06.11.2017).
- Smith, D.** (2004). *Social Work and Evidence-based Practice*. Jessica Kingsley Publishers
- Sotsiaalministeerium** (2011). Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond: Laste ja perede arengukava 2012–2020.
- Zlotnik, J., Galambos, C.** (2004). Evidence-based practices in health care: Social work possibilities. *Health & Social Work*, 29(4), 259–26
- Talur, P.** (2013). Hästi ja/või palju. Mõtteid väärt noorsootööst. *MIHUS*, 14, 10–14.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)** (2015). International Standards on Drug Use Prevention. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna. www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html (06.11.2017).
- Webb, S. A.** (2001). Some considerations on the validity of evidence-based practice in social work. *British Journal of Social Work*, 31, 57–79.